

2026년 제7차 약제급여평가위원회 사전 검토 보고

직전 6차 회고 · 7/2 회의 안건 후보 심층 분석

항목	내용
보고일	2026년 6월 30일 (월)
회의	약제급여평가위원회 2026년 제7차
회의 예정일	2026년 7월 2일 (목)
직전 차수	2026년 6월 4일 제6차 약평위 (HIRA 공식 발표 6월 4~5일, 4개 독립 매체 교차 검증 완료)
위원회	10기 약평위 (위원장: 정현철, 심평원 상근위원 / 연세암센터 출신 중앙내과 전문의 / 한국임상암학회 이사장)
정부 인사	이소영 심평원 약제관리실장 신임 부임 (2026-07-01 정기인사) — 7/2 회의가 신임 실장 체제 첫 정기 약평위
정책 환경	약가 유연계약제(이중약가제) 시행(2026-06-01) · 하반기 회귀 신약 급여화 최대 100일 단축 정책
보고 목적	7/2 회의 사전 안건 후보 분석 — 경영진 의사결정 지원

§1. 들어가며

한국 신약 급여 심의의 1차 권위는 건강보험심사평가원(HIRA) 공식 보도자료다. 매 차수 심의결과는 회의 당일 오후 혹은 익일 발표되며, 다수 의약 전문매체가 이를 신속히 보도한다. 그러나 HIRA 직접 접속이 지속적으로 차단된 환경에서 일부 매체는 약물명·통과 여부·적응증에서 핵심 팩트가 부정확한 보도를 내는 사례가 반복된다. 실제로 2026년 5월 7일 5차 약평위 결과를 전한 일부 보도에서 HIRA 공식 보도자료에 존재하지 않는 약물명이 통과 목록에 포함되었다. 본 보고서는 HIRA 공식 발표를 1차 권위로, 매체 보도는 시장 맥락 해석 및 신호 탐지 보조 역할에만 활용하며, 사전 예측 구간에서는 신호 강도를 명시해 불확실성을 구분한다.

7차 약평위는 세 가지 환경 변화가 중첩되는 시점이다. 첫째, 2026년 7월 1일 심평원 정기인사로 약제관리실장이 교체되어 7/2 회의가 신임 체제 첫 정기 심의 기회가 된다. 둘째, 2026년 하반기부터 회귀 신약 급여화 행정 일정이 최대 100일로 단축되는 정책이 시행돼, 7차 이후 약평위 운영 pace에 구조적 가속 압력이 존재한다. 셋째, 6차에서 테뮌브라(PD-1 면역항암제 5개 적응증 일괄 통과)와 리브리반트(EGFR 엑손20 NSCLC 단독요법 5년 등재 여정 종결)가 통과하면서 면역항암제·표적치료제 심사 환경이 재편됐다. 7차는 이 결과의 직접적 후속 파이프라인이 심사대에 오르는 첫 차수다.

§2. 직전 차수 결과 회고 — 2026년 6월 4일 제6차 약평위

HIRA 공식 보도자료 기준(4개 독립 매체 교차 검증 통과), 제6차 약평위는 5개 의약품·9개 적응증 전체 급여 적정성 인정으로 결론났다. 재심의·미통과는 0건이었다.

통과 약제 전체

#	약물	성분명	회사	주요 적응증	비고
1	지텍정 75mg	건조세포추출물	종근당	급성·만성 위염 위점막 병변 개선	평가가격 이하 조건부 / 종근당 첫 천연물 의약품 급여

#	약물	성분명	회사	주요 적응증	비고
2	빌로이주	줄베특시맵 100/300mg	한국아스텔라스제약	CLDN18.2+/HER2- 절제불가 국소진행성·전이성 위선암 및 위식도접합부 선암 1차 플루오로피리미 딘+백금 병용	—
3	핀테플라	펜플루라민	한국유씨비제약	드라벡증후군 2세 이상 발작 치료 부가요법	희귀질환
4	리브리반트주	아미반타맵	한국얀센	EGFR 엑손20 삽입 변이 NSCLC 백금기반 화학요법 치료 중·이후 국소진행성·전이성 NSCLC 성인 단독요법(2차 이상)	5차 재심의 후 1차수 만에 재상정 통과
5	테빔브라주 100mg	티슬렐리주맵	비원메디슨코리아	① 식도편평세포암 1차 병용(PD-L1 무관·올커머) ② 위암·위식도접합부 선암 1차 병용 ③ 비편평 NSCLC 1차 병용 ④ 편평 NSCLC 1차 병용 ⑤ NSCLC 2차 단독	5개 적응증 일괄 통과

합계: 9개 적응증 전체 통과

6차 결과에서 7차로 이어지는 핵심 시사점 3가지

① 리브리반트 한국 등재 5년 여정 종결 — 재심의→재상정 패턴 재확인

2021년 식약처 허가 이후 암질심 4회 이상 미설정·자진취하·재신청·약평위 첫 진입 후 재심의(5차)를 거쳐 1차수 만에 재상정 통과했다. 약평위에서 재심의 결정을 받은 약물이 자료 보완 후 1~2개월 내 다음 차수에서 통과하는 패턴이 이번으로 세 번째 검증됐다. 이 패턴은 현재 재심의 대기 약물이 없는 상황이지만, 향후 차수에서 재심의 결정이 나는 즉시 다음 1~2차수 안에서의 통과를 최우선 시나리오로 설정해야 한다.

② 테빔브라 식도암 All-comer 통과 — 면역항암제 PD-L1 cutoff 협상 레퍼런스 변화

글로벌 PD-1 면역항암제 중 식도편평세포암 1차 치료에서 PD-L1 발현 무관 전체 환자군(All-comer) 라벨이 한국 약평위에서 그대로 수용된 첫 사례다. 기존 키트루다 식도암 적응증이 PD-L1 CPS ≥ 10 cutoff 기반으로 등재된 것과 대비된다. 한국 면역항암제 협상에서 PD-L1 cutoff 적용 여부가 BIA 통제 수단이었으나, 이번 결정은 All-comer 적응증을 저가 포지셔닝 조건 하에 수용할 수 있다는 신호로 읽힌다.

③ 빌로이(줄베특시맵) 무신호 진입 — 위암 신약 사전 탐지 공백 확인

CLDN18.2 항체 신약이 의약 전문매체 D-14~D-2 구간 거명 0건 상태에서 약평위 안건에 진입·통과했다. 위암·위식도접합부 선암 대상 신규 기전 약물은 사전 매체 신호 부재에도 약평위 직행 안건 진입이 가능하다는 점을 보여준다. 7차 이후에도 위암 계열 신약(HER2 이중항체·VEGFR2 표적·클로딘 계열 병용 등)은 사전 탐지 없이 안건에 등장할 가능성을 열어두어야 한다.

§3. 2026년 7월 2일 제7차 약평위 — 안건 후보 분석

HIRA는 위원회 사전 안건을 공식 공개하지 않는다. 아래 분류는 암질심 통과 이후 전환 소요기간, 재심의·재상정 이력, 매체 신호, 정부 발언 등을 복합 적용한 예측이며, 사전 신호 강도가 명시되지 않은 것은 현재(2026-06-30 기준) 확증 신호가 없음을 의미한다.

Tier 1 — 진입 가능성 높음 (전환 소요기간 범위 내 + 전차수 미진입)

카보메틱스 (카보잔티닙) — 입센·HK이노엔 | 신장세포암

2026년 1월 21일 제1차 암질심에서 신장세포암(신세포암 투명세포암) 단독 적응증 급여기준 설정 이후 현재 6.3개월 경과. 6차 약평위(6/4)에도 진입하지 못해 대기 기간이 추가 누적된 상태다.

암질심 통과 약물의 약평위 전환 소요기간을 2026년 상반기 데이터(자카비·포말리스트·카보메틱스·사이람자 코호트)에 기반해 분석한 결과, 실질 진입 구간은 6~9개월임이 확인됐다. 현재 6.3개월은 이 범위의 시작 지점이며, 6차 미진입 사실이 회사·심평원 간 협의가 마무리 단계에 있을 가능성을 높인다. 6차 보도자료에 카보메틱스 관련 언급이 전무하다는 사실은 7차 대기 가능성을 추가로 시사한다.

통과 가능성 시나리오: 조건부 통과(평가금액 이하 수용 조건) 가능성이 높다. 4차 약평위(4/2)에서 카보잔티닙 계열 약물의 "평가금액 이하 수용" 패턴이 반복된 바 있어, 이번에도 동일 구조가 적용될 가능성이 크다.

사이람자 (라무시루맙) — 한국릴리 | 위암·위식도접합부 선암

카보메틱스와 동일한 2026년 1월 21일 제1차 암질심 통과 이력이며 현재 6.3개월 경과 상태다. 위암 2차 단독(REGARD)·파클리탁셀 병용(RAINBOW) 적응증 확대가 신청 안건으로 추정된다. 위암 급여 라인업이 6차(빌로이·CLDN18.2 항체 통과)로 강화된 후, 사이람자의 VEGFR2 표적 기전이 별개 적응증으로 7차에서 등장할 가능성이 있다. 기전적 중복이 없어 비교 심사 이슈는 제한적이다.

위암 계열 약물이 6차에 이어 7차에도 등장하는 패턴은 위암 신약 pipeline의 빠른 전환 속도를 반영한다. 2018년부터 기존 위암 2차 급여 적응증이 있는 상황에서, 이번 신청은 적응증 확대 트랙으로 진행됨에 따라 BIA 통제 측면에서도 상대적으로 협상 여지가 크다.

Tier 2 — 진입 가능성 중간 (사전 신호 일부 존재 또는 전환 소요기간 내)

옵디보+여보이 (니볼루맙+이필리무맙) — 한국오노·한국BMS | 간세포암 1차 병용

2026년 4월 15일 제4차 암질심에서 간세포암 1차 병용 급여기준 설정 후 현재 2.5개월 경과. 통상 암질심→약평위 전환 소요기간(6~9개월)에 비하면 짧지만, 6월 하순 복수 의약 전문매체에서 "약가협상 돌입 또는 임박" 시그널이 포착됐다. 다만 해당 보도의 원문 직접 확인이 불가능한 상태로 신호 강도는 약세(weak)에 머무른다.

약평위 직전 단계인 약가협상 진행이 확인된다면 7/2 진입이 가능하나, 보다 현실적인 진입 시점은 8차(8/6) 이후다. 니볼루맙 단독 간세포암 1차(옵디보+여보이 병용)의 한국 급여 진입이 실현되면, 소라페닙 이후 간세포암 1차 표준이 크게 재편된다.

엘라히어주 (mirvetuximab soravtansine) — 한국애브비 | FRα+ 백금저항성 난소암

2026년 5월 27일 제5차 암질심 통과 후 현재 약 5주 경과. 보건복지부 당국자가 5월 12일 학술 토론회에서 관련 적응증 약제의 빠른 급여 진입을 거명한 발언이 있어, 전환 가속 신호로 해석된다. FRα 발현 양성 백금저항성 난소암은 국내 기허가 표준 대안이 제한적인 unmet need 영역으로, ICER 협상 여지가 상대적으로 크다.

통상 5주의 전환 결과는 최단 전환 케이스(약 1개월)에 해당하는 만큼, 7차 진입이 사전 신호 부재 상태에서는 early 시나리오다. 8차(8/6)가 보다 안정적인 진입 예상 시점이나, 정부 인사의 사전 거명 발언이 확인된 경우 7차 fast-track 가능성을 배제하지 않는다.

버제니오정 (아베마시클립) — 한국릴리 | HR+/HER2- 조기 유방암 보조

엘라히어와 동일한 5차 암질심(5/27) 통과 이력으로, 현재 약 5주 경과. HR+/HER2- 림프절 양성 고위험 조기 유방암 보조요법이 대상 적응증이다. 동일 분류에서 키스칼리(리보시클립)가 5차 암질심 미설정 상태이므로, 버제니오 단독 진입 시 비교 약제 부재에 따른 협상 여지가 발생한다. 그러나 전환 소요기간 측면에서 7차 진입은 이르고, 8차(8/6)~9차(9/3)가 더 현실적인 진입 구간으로 판단된다.

정기 운영 안건 — 거의 확실

매 약평위 차수에는 신약 심의 외 다음 정기 운영 안건이 포함된다.

약가재평가 결과 반영 — 재평가 주기 도달 기등재 약제의 상한금액 조정

사용량-약가 연동(PVA) 협상 결과 의결 — 7월 약가 조정 대상(렉라자·린버크 등 포함) PVA 완료 약제 반영

결정신청 약제 의결 — 제네릭·동일성분 다수 품목 묶음 심의

§4. 한국 신약 Reimbursement Pipeline Trends

4-1. 2026년 상반기 항암·중증 신약 등재 — 속도와 폭 모두 확대

2026년 1월부터 6월까지(1~6차 약평위 + 1~5차 암질심 기준) 한국에서 급여 적정성 인정을 받은 주요 항암·중증질환 신약은 15종 이상이다. 예스카타(CAR-T)·레테브모(RET 표적)·리브리반트(EGFR 엑손20)·테빔브라(PD-1)·빌로이(CLDN18.2) 등이 상반기 안에 집중 등재됐다. 심평원과 복지부는 2026년 하반기부터 회귀 신약 급여화 행정 일정 최대 100일 단축 정책을 시행함에 따라, 7차 이후 약평위의 등재 pace가 추가로 가속될 가능성이 있다.

4-2. 면역항암제 — 저가 포지셔닝·약가 유연계약 복합 구조 표준화 진행

테빔브라(티슬렐리주맵)의 6차 5개 적응증 일괄 통과는 PD-1/PD-L1 면역항암제 시장에서 기존 표준약제(키트루다) 대비 저가 포지셔닝이 실질적 한국 통과 전략으로 확립됐음을 보여준다. 6월 1일 시행된 약가 유연계약제(이중약가제)는 RSA와 복합 부착이 가능해, 면역항암제 등재 협상에서 '조건부+RSA+유연계약' 다중 위험분담 구조가 표준화될 것으로 보인다. 한국MSD는 키트루다 신규 적응증 신청 시 이 경쟁 환경을 반영한 약가 전략 재점검이 필요한 시점이다.

4-3. CAR-T — 등재 표준 미확립, 예스카타가 첫 실전 약가협상 시작

예스카타(axicabtagene ciloleucel, 길리어드코리아)가 5차 약평위 3차 적응증(DLBCL 2차 이상 전신치료 후) 조건부 통과 후 NHIS 약가협상 단계에 진입했다. 이 협상이 한국 최초의 CAR-T 약가협상 케이스로, 결과가 이후 림카토(국산 CAR-T)·김리아(노바티스) 등 후발 CAR-T 등재의 가격 천장(price ceiling)이 된다. 현재 림카토(큐로셀)는 5차 암질심 미설정 후 7월 8일 6차 암질심 재상정을 예고한 상태다.

4-4. 소세포폐암 — 임델트라, 사회적 이슈화로 7/8 6차 암질심 핵심 안건으로 부상

탈라타맵(임델트라, 암젠코리아)은 1차 암질심(1/21) 미설정 이후 의사단체·환자단체·국회 청원(5만 2,647명 성원으로 국회 보건복지위원회 심사 진입 확정)까지 동원된 사회적 급여 이슈로 전면화됐다. 7월 8일 6차 암질심이 임델트라의 첫 재상정 시점이 될 가능성이 높으며, 국회 압력을 받은 심평원·복지부의 심사 가속 유인이 있다. 국내 소세포폐암 2차 표준 급여 약제가 아직 없는 상황에서 ICER 임계값 적용 여부가 상대적으로 크다는 점도 통과 가능성에 유리하게 작용한다.

4-5. 하반기 약가협상 — 리브리반트·테빔브라·빌로이 동시 진입, MSD 직접 영향

6차 통과 리브리반트(아미반타맵)·테빔브라(티슬렐리주맵)·빌로이(줄베특시맵) 등은 2026년 하반기 NHIS 약가협상 → 건정심 → 급여 고시 단계로 진입한다. MSD 관점에서 주목할 지점:

리브리반트 약가협상 결과 — EGFR 엑손20 단독요법 약가 수준이 확정되면, 향후 렉라자(라즐러티닙)+리브리반트 병용요법 급여 신청 시 병용 약가 협상 구조의 레퍼런스가 된다.

테빔브라 저가 포지셔닝 확정 폭 — PD-1 면역항암제 신규 진입자의 키트루다 대비 가격 할인 폭이 공개되면, 향후 키트루다 신규 적응증 협상에서 경쟁 기준이 재설정된다.

키트루다 약가협상 진행 중 — 6월 보도 기준 키트루다 다수 적응증 약가협상이 NHIS와 진행 중이며, 7~8월 협상 마감 및 연내 고시 가능성이 있다.

본 보고서의 안건 예측은 공개 정보 기반 추정이며, HIRA 공식 보도자료 발표 전까지 최종 안건 확정 기준으로 사용할 수 없습니다. 7/2 회의 결과는 HIRA 공식 보도자료 발표 후 익일(2026-07-03) D+1 리뷰 보고서로 대체됩니다.